

Esfínter urinario artificial (EUA)

WARWIKI

Información para el paciente · Qué esperar antes de su cirugía de EUA

Un esfínter urinario artificial (EUA) es un dispositivo pequeño, colocado completamente debajo de la piel, que restaura el control de la vejiga cuando usted pierde orina — con mayor frecuencia después de una cirugía de la próstata. Usted mismo lo controla con una bomba escondida en el escroto. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

La pérdida de orina con la actividad, al toser o al levantar peso se llama **incontinencia urinaria de esfuerzo**, y a menudo ocurre después de una cirugía de la próstata. El EUA la trata con tres partes conectadas, todas escondidas debajo de la piel:

- Un **manguito** blando alrededor de la uretra (el tubo por donde sale la orina) que la aprieta suavemente para cerrarla y mantenerlo seco
- Una **bomba** en el escroto que usted presiona para orinar
- Un **balón** pequeño en la parte baja del vientre que fija la presión

Cómo lo usa: normalmente el manguito permanece cerrado y lo mantiene seco. Cuando necesita orinar, aprieta y suelta la bomba unas cuantas veces — el manguito se abre y usted orina. Unos minutos después, se vuelve a llenar y se cierra por sí solo.

¿Es seguro?

El EUA es el tratamiento de referencia desde hace mucho tiempo para este tipo de pérdida, y la mayoría de los hombres logran muy buen control. Como cualquier implante, conlleva algún riesgo — principalmente infección, o desgaste del dispositivo o de la uretra con el tiempo, que puede requerir una reparación posterior. Su equipo reduce el riesgo de infección con antibióticos, técnica estéril y tratando primero cualquier infección de orina.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Pérdida de orina con la actividad, al toser o al levantar peso.

Uretra

El tubo que lleva la orina fuera del cuerpo.

Manguito

La parte del dispositivo que aprieta suavemente la uretra para cerrarla y mantenerlo seco.

Bomba

La parte en el escroto que usted presiona para abrir el manguito y orinar.

Activación

Encender el dispositivo en una visita unas 6 semanas después de la cirugía, una vez cicatrizado.

Desactivación

Apagar el dispositivo (manguito mantenido abierto) — necesario antes de cualquier sonda.

Anestesia general

Medicamento que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

Cistoscopia

Una revisión con cámara de la uretra y la vejiga, que a menudo se hace antes de la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que no siente nada. Después, espere dolor, hinchazón y moretones en el escroto y el periné un par de semanas — ayudan un soporte escrotal, hielo y analgésicos. Dura 1–2 horas y muchas personas se van a casa el mismo día.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicamentos suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** revisa si hay infección — una infección debe tratarse primero, así que la cirugía puede reprogramarse si usted tiene una.
- No fume ni vapee**; báñese con cualquier **jabón antiséptico** que le den y tome los antibióticos según le indiquen — esto es un implante, así que prevenir la infección es una prioridad.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Ha recibido **radiación** en la pelvis, o tuvo una cirugía previa de la uretra o de la incontinencia
- Tiene **diabetes**, o dificultad para usar las manos (usted mismo opera la bomba)
- Tiene alguna infección, en cualquier parte

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido o adormecido de la cintura para abajo con anestesia, y se le dan antibióticos.
- 2 A través de incisiones pequeñas, el cirujano coloca el **manguito** alrededor de la uretra, el **balón** en la parte baja del vientre y la **bomba** en el escroto — todo debajo de la piel.
- 3 El dispositivo se llena y se prueba, y luego se **deja apagado** para que todo pueda cicatrizar.

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón y moretones** en el escroto y el periné 1–2 semanas. Use soporte escrotal y hielo, y evite **peso, esfuerzo, bicicleta y relaciones** el tiempo que le indiquen.
- El dispositivo queda APAGADO unas 6 semanas.** Seguirá perdiendo orina y debe usar protectores — es normal. **No presione la bomba** hasta que su cirujano la encienda.
- Unas **6 semanas después, su cirujano lo enciende** y le enseña a usar la bomba.
- Avisé siempre que tiene un EUA** — debe apagarse antes de cualquier sonda, o puede lesionar la uretra. Lleve una tarjeta de alerta médica.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre, escalofríos, o enrojecimiento, dolor o secreción cada vez mayor en una incisión
- De repente no puede orinar en absoluto
- Un escroto que se vuelve muy hinchado, duro o cada vez más doloroso

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un EUA es un dispositivo oculto que restaura el control de la vejiga — un manguito lo mantiene seco y usted aprieta una bomba para orinar.
2. Permanece **APAGADO durante unas 6 semanas** (todavía perderá orina — eso es normal), luego se enciende y le enseñan a usarlo.
3. Prevenir la infección es lo más importante: trate primero cualquier infección, no fume y use el lavado antiséptico y los antibióticos. **Avisé siempre que tiene un EUA — debe estar apagado antes de cualquier sonda.**